

40 - Suites De Couches Normales Et Pathologiques - Pr. AIT BENKADDOUR

Ce cours est destiné aux étudiants de cinquième année des études médicales dans le cadre du module de gynécologie obstétrique de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. C'est le cours sur les suites de couches normales et pathologiques. Cette entité est définie comme étant la période qui débute après 24 heures de l'accouchement, c'est-à-dire après la période qu'on appelle la période de délivrance et qui va se prolonger jusqu'au retour de couche, c'est-à-dire les premières menstruations normales, évidemment, chez la patiente qui n'allait pas.

Et donc, on va considérer que c'est aux alentours de 6 à 8 semaines après l'accouchement. Le retour de couche a eu lieu, en général, au bout de 6 à 8 semaines chez la patiente qui n'allait pas et au-delà de 3 mois, en général, on considère que ce retour de couche tardif et pathologique, évidemment, on parle toujours chez la patiente qui n'allait pas. Chez les patientes qui allaitent, ce retour de couche est en général retardé jusqu'au 6e, voire au 9e mois en fonction des patientes et en fonction aussi de la fréquence de l'allaitement.

Cette période qui va durer pratiquement 6 semaines après l'accouchement et qui démarre après 24 heures de l'accouchement est une période très importante. Sur le plan physiologique, il s'agit d'une période où on aura un retour de l'organisme maternel anormal. Elle est aussi importante à étudier et à connaître parce qu'un certain nombre de complications peuvent survenir et il faut les reconnaître, les prévenir puisque un certain nombre d'entre elles peuvent constituer des complications graves pouvant mettre en péril le pronostic vital.

Il s'agit essentiellement des complications infectieuses, hémorragiques, thrombotiques, en plus des complications de l'allaitement maternel. Sur le plan physiologique, comme on a dit, c'est un retour de l'organisme à l'état normal et qui va se faire de manière progressive. Évidemment, l'organe qui a connu la plus grande partie des changements c'est essentiellement l'appareil génital et notamment l'utérus.

Celui-ci, suite à la chute des hormones qui étaient sécrétées par le placenta, immédiatement après l'expulsion du placenta, va assister à une chute brutale des taux d'oestrogène et de progestérone et qui va donner une involution utérine progressive qui va durer pratiquement 15 jours. Après les 10 premiers jours, l'utérus va reprendre sa position pelvienne, c'est-à-dire qu'il va arriver pratiquement à la limite du pubis et donc vous voyez que d'un utérus qui pesait pratiquement 1000 g, il va repasser à un poids de pratiquement 50 g. Cette involution est favorisée, comme on l'a vu, par la chute des hormones et donc la diminution de l'imbibition gravidique et aussi par la contractilité utérine secondaire à la sécrétion de l'ocytocine et qui est amplifiée par l'allaitement maternel et de ce fait, l'allaitement va favoriser l'involution utérine et aussi évidemment par conséquent réduire le risque d'hémorragie en favorisant cette involution utérine. L'utérus va atteindre sa taille normale prégestationnelle, en général, au bout de 2 mois au maximum et donc l'application clinique, c'est qu'en général on va retarder la mise en place des

stérilisés à cette date-là pour éviter l'expulsion.

Le segment inférieur disparaît en 2 jours et le col qui a été modifié, dilaté, effacé va se reconstruire en général et reprendre sa longueur de 1,5 à 2 cm au bout d'une semaine. L'orifice interne va se fermer là aussi au bout d'une semaine et l'orifice externe va rester un peu béant jusqu'au 20e jour et il va se transformer comme c'est connu. Le col de la nullipare qui n'a jamais accouché par voie basse est peintiforme, alors le col de la multipare va devenir plutôt transversal.

Sur le plan périnéal et endométrial, il y aura des changements puisque l'endomètre va régresser, donc il y aura une chute et une élimination de toute la couche fonctionnelle durant les 5 premiers jours sous forme de ce qu'on appelle l'élochi. Puis il y aura une phase de cicatrisation qui va durer pratiquement 3 semaines à partir du 6e jour jusqu'au 25e jour et c'est une réparation, une cicatrisation qui va se faire par les mécanismes de réparation de cicatrisation classique et qui est non hormonodépendante. Après le 26e jour, on va assister à une reprise du cycle endométrial par une prolifération sous contrôle hormonal notamment oestrogénique durant cette phase-là et donc là, c'est d'où l'intérêt de démarrer la contraception en général après cette date-là puisque si jamais il y a une ovulation à partir de cette date-là, le risque de grossesse existe.

Donc le cycle va reprendre en général à partir de 45 jours, donc on va assister à ce qu'on appelle une hémorragie de privation évidemment chez la patiente qui n'allait pas. Chez la patiente qui allaite, sous l'effet de l'augmentation de la prolactine, on peut assister à un arrêt de l'ovulation sur plusieurs mois. Donc l'ovulation est possible dès le deuxième cycle, mais en général la grossesse est très très très rare.

S'il y a un allaitement, on a dit que la reprise du cycle et des règles est dépendante des patientes, dépendante aussi de la fréquence de l'allaitement et de son importance, et en général au bout de 4 mois jusqu'à 9 mois. Donc la vulve reste veillante du fait de la dilatation qui a eu lieu au cours de l'accouchement et donc il y aura une reprise du tonus de manière progressive et ce tonus va dépendre de la qualité de l'accouchement, est-ce qu'il a été traumatique ou non, et aussi de la présence d'une déchirure ou d'une épisiotomie. Les glandes mammaires se sont développées au cours de la grossesse et au cours de, immédiatement après la chute des oestrogènes et des progestérones, qui constituaient un blocage de l'action de la prolactine, on va assister à la montée laiteuse sous l'effet de la prolactine et la lactation va être entretenue par la suite, par la succion.

Donc on a dit sur le plan hormonal, il y aura une chute des oestrogènes suite à l'expulsion du placenta et on va assister à une période d'hypo-oestrogénie durant les premiers jours après l'accouchement. La prolactine va augmenter et surtout son effet va s'exercer puisque au cours de la grossesse, la prolactine est aussi augmentée en fin de grossesse mais son action est bloquée par les oestrogènes. Sur le plan humoral aussi, on va assister à une diminution des besoins en insuline, donc diminution de l'insuline en résistance créée par l'état gravidique.

Sur le plan hématologique, il y aura une diminution du volume sanguin, une augmentation des globules blancs et une augmentation du fibrinogène dans le cadre de l'augmentation de la coagulation, ce qui va améliorer les performances de l'hémostase immédiatement après l'accouchement mais de l'autre côté exposer à un risque de maladie thrombotique. Sur le plan musculo-squelettique, on va assister à une relaxation des articulations du pelvis, une fatigue musculaire générale suite à l'accouchement et un diastasis du muscle abdominal. Sur le plan psychologique, il y a aussi des changements dans le postpartum et ça constitue des phénomènes d'adaptation à une nouvelle situation sociale, familiale qui est la présence d'un être humain qui est totalement dépendant de la mère et donc ce mécanisme d'adaptation est très différent en fonction des patientes mais aussi en fonction des cultures.

Il peut être classé en quatre phases. La première phase, c'est une phase de réflexion. C'est un temps de réflexion concernant le nouveau-né et va durer en général une à deux journées à laquelle va suivre une phase de reprise avec un début d'autonomie et de soins du nourissant en général habituellement deux ou trois jours.

Il peut se produire dès le premier jour chez la multipart qui a de l'expérience et qui a déjà passé cette étape dans les grossesses précédentes. Ensuite, une phase de réalisme. Quelques semaines après, surtout après le retour à domicile, la patiente prend conscience des nouvelles responsabilités et va s'adapter à de nouvelles expériences et des besoins.

Par la suite, la relation avec son nouveau-né s'est bien installée et donc c'est la phase d'attachement. Après ce bref rappel sur la physiologie de la période des suites de couches, on va passer à l'étude clinique. Sur le plan clinique, les signes fonctionnels qu'on va observer au cours de cette période de suite de couches, c'est d'abord les sécrétions qui vont être extériorisées qu'on appelle les lochi et qui correspondent à des météorologies physiologiques du postpartum qui sont constituées par un mélange d'érythrocytes, cellules hypothéliales, du sang, des fragments d'endomètres, du mucus et des bactéries.

Ce sont des sécrétions qui ne sont pas totalement sanglantes, ont une odeur fade mais qui ne sont pas fétides et il faut faire attention parce que s'ils sont fétides, ça veut dire que c'est pathologique. Ces saignements sont abondants avec du sang non coagulé pendant les trois premiers jours puis ils vont devenir sérosanglants et puis ils sont de plus en plus rosés et séreux jusqu'à se tarir. On peut avoir parfois ce qu'on appelle un petit retour de couche, c'est des petits saignements vers le 15^e jour qui ne sont pas pathologiques s'ils sont peu abondants et limités dans le temps et ça correspond à des écoulements sanguinolents peu abondants et peuvent persister parfois plusieurs semaines.

Deuxième signe clinique ou signe fonctionnel qu'on observe durant les suites de couche, c'est les tranchées qui correspondent à des contractions intermittentes et qui sont douloureuses. Elles sont particulièrement douloureuses chez la patiente deuxième part. Elles sont rarement très douloureuses chez la première part et donc il s'agit de contractions suite à l'augmentation de la

sécrétion d'ocytocine et qui sont favorables pour l'involution utérine.

Parfois, dans les suites de couche, on peut assister à une débâcle urinaire. À l'examen clinique, on va apprécier ce qu'on a vu en physiologie, c'est l'involution de l'utérus et qui, normalement, dans les 48 heures après l'accouchement, est à mi-chemin entre l'embrylique et le pubis et on a dit qu'il va arriver au pubis au bout d'une à deux semaines. Le col va se former et se fermer en deux semaines.

Le vagin et la vulve sont légèrement distendus après l'accouchement et vont reprendre leur tonus et avec une muqueuse qui est plus ou moins atrophique durant les premières semaines. Le périnée peut être oedémateux ou équimotique suite au traumatisme de l'accouchement ou à une déchirure ou à une épisiotomie et il faut attendre la cicatrisation et le retour à la normale de ce périnée avant d'entreprendre une rééducation. Sur le plan prise en charge, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre en charge une femme qui vient d'accoucher ? C'est essentiellement d'abord la surveillance qui a comme but de guetter, de rechercher des signes de complications ou aussi des facteurs de risque de complications.

Les modalités de surveillance peuvent se faire soit en hospitalier ou, beaucoup plus fréquemment actuellement, à domicile par des visites de sages-femmes à domicile ou des consultations des patientes en général de ce qu'on appelle la consultation du post-partum qui peut se faire au bout d'une semaine. Qu'est-ce qu'on va observer ? On va essayer de rechercher les complications notamment infectieuses, hémorragiques et thrombotiques et pour ça, il faut faire un examen général et un examen gynécologique et il faut surtout avertir la patiente sur les signes qui peuvent alerter sur la présence d'une complication, notamment de la fièvre, des douleurs péloviennes ou des saignements non expliqués. Qu'est-ce qu'on va dire à la patiente ? Les conseils pour éviter les complications et les soins, que ce soit après un accouchement par voie basse ou après une césarienne.

C'est d'abord le lever précoce, une alimentation équilibrée avec une supplémentation, le plus souvent en fer. Il faut encourager l'allaitement maternel et on va traiter quelques anomalies s'ils existent, notamment s'il y a une rétention aiguë d'urine qui est souvent secondaire un tonus parasympathique secondaire à la douleur donc on va soit faire un sondage ou des anticholinergiques. S'il y a une hypogalaxie, on va conseiller des boissons abondantes, une alimentation riche et équilibrée et aussi une supplémentation en fer.

La sortie de la patiente de la maternité doit se faire toujours en sécurité et pour ça deux paramètres, c'est d'abord l'examen de sortie et deuxièmement les consignes de sortie. Le plus souvent dans notre contexte au Maroc, les patientes sortent de la maternité au bout de 24 heures voire de 12 heures lorsque l'accouchement n'est pas compliqué, la patiente n'est pas à risque de complications. Donc à la sortie il faut examiner la patiente, prendre ses constantes notamment le pot, la température et la tension artérielle examiner les mollets et faire un toucher vaginal qui est très important avant de déclarer la sortie puisqu'il a trois rôles.

D'abord évaluer la tonicité des muscles périnéaux et vérifier l'absence de saignements. Deuxièmement rechercher d'éventuels compresses parfois oubliées lors de la réfection de l'épisiotomie et troisièmement mobiliser l'utérus et voir est-ce qu'il n'y a pas de douleurs exquises lors de la mobilisation. On palpe le globe pour vérifier qu'il est tonique et en involution et on examine le sein à la recherche des complications de l'allaitement maternel.

Les consignes de sortie, surtout dans notre contexte où les patientes vont sortir très précocement de la maternité, on va les avertir sur tous les signes de complications notamment la présence des saignements plus abondants que des règles, deuxièmement la douleur pélvienne, surtout si elle est permanente, la fièvre et les lochis, les caractéristiques des lochis. On va lui dire que si les lochis sont purulentes ou bien s'ils sont fétides c'est un signe qui est anormal et qu'il devrait se réadresser soit à la maternité, soit au centre de santé ou à son médecin traitant si jamais il y a une de ces anomalies qu'on a citées. Donc on va lui dire qu'il faut soigner son épisiotomie si elle existe ou bien une suture de déchirure essentiellement par le nettoyage et le séchage.

Si elle a une cicatrice de césarienne on va lui donner les consignes pour les soins de plaie. On va avertir la patiente, comme on a dit, sur les signes d'infection, des conseils sur la nutrition, le sport à quel moment elle peut le reprendre. On va traiter la douleur surtout après une césarienne essentiellement par les antalgiques usuels.

Les anti-inflammatoires sont en général à déconseiller si la patiente a l'activité sexuelle et la contraception. Dernière consigne, c'est sur la rééducation européenne et idéale qui est conseillée voire recommandée chez les patientes qui ont accouché par voie basse mais aussi par césarienne en général 6 semaines après l'accouchement par voie basse et 10 semaines après une césarienne, on conseille de la réalisation d'un renforcement des muscles périnéaux par des séances de rééducation périnéale en général 10 séances. Ça va permettre de prévenir le survenu de prolapsus vaginal ou urogénital et d'un continu sur une heure d'effort.

On donnera aussi des conseils sur la contraception du post-partum qui devrait être recommandée et en tout cas proposée à toutes les femmes qui le souhaitent et leur donner l'information que l'ovulation peut reprendre dès le premier mois qui suit l'accouchement et la reprise des rapports sexuels en général est possible dès l'arrêt des lochis. Les moyens contraceptifs possibles chez la femme dans les suites de couches c'est essentiellement les microprogestatifs vu le risque thrombotique élevé durant le premier mois la contraception oestro-progestative est totalement contre-indiquée durant le premier mois alors que la contraception par microprogestative est tout à fait possible dès la sortie de la maternité on peut la commencer soit au 15ème ou 21ème jour sans aucun problème c'est une contraception par microprogestatif et de ce fait là la prise doit être en continu et à heure fixe les oestro-progestatives peuvent être utilisées chez la patiente qui n'allait pas mais après le premier mois. Le stérilet est possible et on peut le poser en général au bout de 1 à 3 mois après

l'accouchement on le posera un petit peu plus en retard si la patiente a accouché par césarienne les autres méthodes notamment les méthodes locales peuvent être conseillées aux patientes qui ont des contre-indications ou qui ne désirent pas prendre de la pilule ni poser un stérilet sachant que ces méthodes sont moins efficaces la ligature tubér qui est actuellement réalisée essentiellement s'il y a une contre-indication à la grossesse peuvent être faites soit dans les suites de couches ou bien parfois lors de césarienne si la patiente a accouché par césarienne après la sortie de la patiente en général il est recommandé de revoir la patiente après une semaine pour vérifier l'évolution et voir le déroulement des suites de couches pour détecter les complications possibles et on va reprendre l'examen génital pour voir est-ce qu'il n'y a pas de locifétides pas de saignement et l'évolution de l'utérus on réalisera aussi l'examen des seins où on va vérifier la montée laiteuse et on va voir est-ce qu'il n'y a pas des anomalies notamment des crevasses ou un engorgement qu'il faudra traiter si la patiente ne désire pas faire ou ne peut pas à cause d'une contre-indication avoir un allaitement maternel et donc il va avoir recours à l'allaitement artificiel la montée laiteuse peut être arrêtée ou bloquée par la bromocryptine qu'on va utiliser à la dose de un comprimé ou deux comprimés par jour qu'on aurait commencé de manière progressive dès le premier jour après évidemment ce sont des médicaments qui sont contre-indiqués s'il y a une hypertension artérielle qu'elle soit chronique ou gravidique comme on a dit on vérifiera l'involution utérine l'existence de locifétides ou autres anomalies si la patiente a des tranchées il faut les traiter on examinera la cicatrice de césarienne à la recherche de zones endurées, inflammatoires ou d'infections et on vérifiera la cicatrisation d'une épisiotomie ou d'une déchirure et aussi le tonus du périnée donc la patiente aurait eu toutes les informations concernant les soins d'épisiotomie avec des toilettes au savon et le séchage comme on l'a déjà dit on examinera les membres inférieurs à la recherche des thrombophilités par les signes classiques, le test de Hohmanns et la recherche d'une induration du trajet veineux d'une douleur surtout à la flexion une diminution du déballotement donc les patientes qui ont accouché par césarienne vu le risque lié au post-opératoire et au post-partum auront toujours une prescription d'héparine de bas poids moléculaire les patientes qui ont accouché par voie basse en général c'est juste les conseils de prévention notamment le port de bas de contention et le lever précoce et la mobilisation précoce donc après avoir vu la prise en charge clinique des suites de couches normales on va parler des suites de couches pathologiques et des différentes complications donc comme on a dit les complications sont surtout infectieuses ce qu'on appelle les infections purpurales, hémorragiques les complications de l'allaitement et les aménorées et la maladie thrombotique ainsi en dernier les complications psychologiques qui sont spécifiques à la période du post-partum on va commencer par les infections donc il faut avoir à l'esprit dans les suites de couches d'abord que toute fièvre n'est pas nécessairement en rapport avec le post-partum ou avec une infection que la patiente peut avoir d'autres infections intercurrentes deuxièmement que la fièvre n'est pas toujours d'origine infectieuse par exemple dans le cadre de la montée laiteuse qui va donner un fibricule classique et en cas d'antibiothérapie il faut tenir en compte l'allaitement maternel donc c'est ce qui fait la spécificité des infections au cours de cette période donc les facteurs de risque d'avoir une infection purpurale c'est d'abord un

accouchement instrumental, la réalisation de gestes ondo-utérins, le non-respect de l'asepsie la mauvaise hygiène, l'existence d'une situation infectieuse pré-partum notamment de rupture prématurée de membrane ou d'infection soit génitale ou urinaire lors de l'accouchement ou immédiatement avant le travail prolongé et comme on a dit les manoeuvres ondo-utérines au cours de l'accouchement et la césarienne elle-même est un facteur de risque d'infection les germes en cause sont en général les germes qui sont qui s'profitent de la flore génitale et donc c'est essentiellement les BGN les bacilles grammes négatives comme les *chérichia coli* le *clebsiella*, aussi les grammes positives notamment le streptocoque surtout le streptocoque D et les anaerobies donc l'étude clinique on va voir d'abord la forme type qui est l'endométrite des suites de couche qui est plus ou moins fréquente évidemment par rapport aux autres formes et qui va apparaître le plus souvent vers le quatrième, cinquième jour après l'accouchement si elle est négligée ou maltraitée cette infection qui est entre guillemets banale, facilement traitable peut évoluer pour des formes graves qui peuvent mettre en péril le pronostic vital donc l'endométrite va se manifester par un fébricule puis va s'installer une fièvre avec une température de 38 à 39 avec des frissons, l'existence de douleurs pelviennes et de loci qui sont fétides.

A l'examen un signe assez caractéristique c'est la douleur à la mobilisation de l'utérus et la douleur vive au toucher vaginal ainsi qu'un utérus mal involué et l'existence de loci Si cette endométrite est négligée ou non diagnostiquée ou maltraitée, elle peut évoluer vers des formes propagées vers le pelvis notamment vers une pelvipéritonite qui va se manifester par une défense pelvienne localisée donc sans contracture associée à des loci et à un utérus douloureux à la mobilisation Cette infection peut aussi diffuser vers les trompes et donner un piosalpinx ou diffuser vers le paramètre et réaliser le tableau d'un fléguement du ligament large ou constituer un abcès collecté notamment dans le cul de sac de Douglas et donc ça va donner un tableau de sepsis avec une température élevée à 39°C jusqu'à 40°C un faciès toxique, parfois des signes digestifs de type diarrhée et météorisme avec une défense mais qui est limitée au pelvis donc sans contracture abdominale et au toucher vaginal, donc on va retrouver une masse au niveau du cul de sac de Douglas ou un bandement du cul de sac de Douglas ou une douleur très importante au niveau du cul de sac de Douglas ce qui va évoquer une infection localisée avec une absédation et donc indiquer un traitement médical et en même temps chirurgical La diffusion vers la cavité péritoniale va donner le tableau de péritonite généralisée avec une fièvre plus importante et une contracture abdominale généralisée et évidemment c'est une infection grave, si elle n'est pas traitée, il y a un risque de choc septique et de décès de la patiente. On peut aussi voir des tableaux graves avec du thromboflébite supéré pelvien qui sont parfois de diagnostics difficiles ou une diffusion hématogène qui va réaliser une septicémie ou voire même une septicopioémie donc le traitement de ces infections va dépendre de leur gravité et donc sur le plan bactériologique, l'antibiothérapie doit être axée sur les germes suspects donc on démarrera par une antibiothérapie probabiliste qui va essayer de couvrir les bacilles grammes négatives, les cocci grammes positifs et les anaerobies en attendant de faire le prélèvement des loci et l'étude de l'antibiogramme donc les formes mineures à modérer on traitera en général par voie parentérale ou si les formes sont mineures par voie orale et on aura la possibilité soit d'utiliser de

l'amoxicilline acide clavulanique ou l'association clindamycine et gentamicine. Dans les formes majeures, on utilisera la voie parentérale avec une triple association amoxicilline gentamicine et metronidazole.

On utilisera en association les utérotoniques une perfusion d'ocytocine pour améliorer l'involution utérine et dans les cas où on a une forme propagée comme la pelvipéritonite ou la péritonite généralisée ou l'abcès du douglas ou bien une évolution défavorable, on aura recours à une chirurgie pour le lavage et l'évacuation des collections abscondées. Evidemment, la prise en charge de ces infections va être en premier préventive par le respect des règles de l'asepsie lors de la réalisation des accouchements, par l'utilisation de l'antibioprophylaxie qui correspond à une seule dose d'antibiotiques administrées lors des gestes endo-utérins comme la révision utérine ou lors des césariennes ou dans les cas où on a une rupture prématurée de membrane et surtout le respect des règles de l'antibiothérapie et des indications des interventions obstétricales afin de réduire le risque infectieux. Deuxième catégorie de complications du postpartum, ce sont les complications hémorragiques, ce qu'on appelle les hémorragies de suite de couche et qui correspondent à un retour de couche hémorragique.

Ce sont des complications qui ne sont pas très fréquentes et lorsqu'on a une hémorragie qui se déclare tardivement, c'est-à-dire au-delà des premières 24 heures, notamment vers le cinquième ou le septième jour, voire même au-delà, il faut avoir le réflexe de vérifier est-ce que ce n'est pas une endométrite dans sa forme hémorragique parce que l'endométrite peut se manifester par des saignements. Il faut aussi vérifier s'il ne s'agit pas d'une rétention placentaire et dans ce cas-là, l'échographie est systématique et ceci peut être favorisé par l'insuffisance oestrogénique. Le traitement est donc en cas de rétention, la réalisation d'un curage digital, l'utilisation d'utérotonique ou s'il y a une infection, une antibiotérapie.

Troisième complication, c'est l'aménorée qui peut être secondaire à un problème mécanique ou un problème hormonal. On définit une aménorée du post-partum comme l'absence de retour de couche dans les délais physiologiques, donc 8 semaines en l'absence d'allaitement et 5 mois en cas d'allaitement. Comme on a dit, les causes à éliminer, c'est d'abord éliminer une nouvelle grossesse, deuxièmement, s'il y a un contexte soit infectieux ou de gestes endo-utérins, on pensera à une synéchie, c'est-à-dire à des adhérences intra-utérines ou parfois à une cause hormonale, soit une aménorée anovulatoire par cause épophysaire dans le cadre soit d'une hyperprolactinémie ou d'une cause ovarienne qui était connue avant même l'accouchement ou d'une aménorée psychogène ou dans le cas spécifique du syndrome de Sheehan qui réalise donc une insuffisance hypothalamo-épophysaire suite à une hémorragie de la délivrance grave qui a entraîné un collapsus et une nécrose épophysaire qui va se manifester par une aménorée donc il faudra évidemment rechercher l'insuffisance épophysaire dans les autres axes.

La quatrième complication ce sont les complications thrombo-emboliques et qui peuvent apparaître dès la première semaine et voire après. Donc la forme la plus fréquente est la

thrombophlébite surrénale qui est favorisée par les modifications de l'hémostase entraînées par la grossesse et les suites de couches mais aussi par l'immobilisation prolongée des patientes surtout et aussi par les césariennes. Elles peuvent aussi être favorisées par un mauvais état veineux.

Les patientes qui ont des varices et une insuffisance veineuse au cours avant la grossesse et au cours de la grossesse ont un facteur de risque supplémentaire. Évidemment les patientes qui ont des antécédents de phlébites ou d'embolie ont un risque beaucoup plus élevé. L'âge maternel et l'obésité constituent aussi des facteurs de risque.

Donc sur le plan clinique la thrombophlébite surrénale va se manifester par une hyperthermie mineure, une dissociation pour température et les signes locaux donc un œdème des membres inférieurs, un mollet qui est douloureux et un signe de Homan's positif. C'est une urgence médicale et de ce fait là il faut rapidement faire une échographie Doppler afin de confirmer et démarrer un traitement à base d'anticoagulants notamment des héparines de bas poids moléculaires immédiatement. Si la patiente n'allait pas on peut assurer le relais par des AVK.

C'est une complication grave et donc l'intérêt de la prévention notamment par le lever précoce, la mobilisation et l'héparine en cas de facteur de risque notamment en cas de césarienne. C'est un diagnostic important puisqu'il va conditionner deux choses, d'abord le mode de contraception chez ces patientes là puisque la pilule oestroprogestative est formellement contre-indiquée par la suite et deuxièmement la prise en charge lors des futures grossesses et aussi des interventions chirurgicales donc c'est une patiente qui devient à haut risque d'avoir des récurrences de maladies thrombo-emboliques. Cinquième complication, c'est les complications psychologiques et donc deux grands tableaux, puisqu'on a vu que sur le plan psychologique il y a des modifications aussi dans la suite du postpartum, ce qui constitue une période de fragilité et de susceptibilité psychologique du fait de la fatigue déjà physique secondaire à la grossesse et à l'accouchement et surtout aux nouvelles responsabilités de la patiente qui devient non seulement responsable d'elle-même mais aussi responsable de son nouveau-né.

Donc il y a deux tableaux, le premier tableau c'est le tableau mineur qu'on appelle Baby Blues qui correspond plutôt à un trouble anxieux et qui peut être surmonté le plus souvent facilement grâce à un soutien de l'environnement. Parfois on peut avoir des tableaux graves notamment de psychose ou de dépression grave. Donc les Baby Blues c'est un syndrome dépressif mineur associé à de l'anxiété caractérisé par des sentiments d'insuffisance et d'incapacité donc la femme se doute par rapport à ses capacités et ce qu'elle peut surmonter ses nouvelles responsabilités.

En général ça va apparaître vers le troisième, quatrième jour après l'accouchement et souvent ça va céder rapidement il n'y a pas besoin de traiter par les anxiolytiques ni les antidépresseurs et juste un soutien médical et surtout social avec un encadrement par la famille sont suffisants pour surmonter ces difficultés. Contrairement à la psychose postnatale qui est une manifestation psychiatrique très grave et pouvant conduire à des cas de suicide ou d'infanticide d'où l'intérêt de

prendre de manière très sérieuse et très urgente ces patientes nécessitent d'hospitalisation en milieu spécialisé et avec une prise en charge spécialisée. Donc ce sont des patientes qui vont avoir des signes prémonitoires notamment d'angoisse et d'insomnie et le tableau est un tableau clinique assez évocateur de délire, de bouffée d'angoisse avec parfois des confusions et alternance de phases de dépressive et d'excitation.

La prise en charge doit être spécialisée. En général l'évolution est favorable si le traitement est adapté mais cette patiente devient à risque de récurrence pour les grossesses ultérieures ce qu'il faut prendre en considération lors de sa prise en charge. Donc après avoir vu toutes ces complications on arrive à la dernière partie qui concerne un aspect important des suites de couches c'est l'allaitement maternel.

Donc on va voir quelques notions de la physiologie puis passer aux complications de l'allaitement maternel. Donc le sein qui est une glande importante et qui a un rôle essentiellement d'allaitement va se voir sa croissance et son développement achevé au cours de la période de grossesse et donc sous l'effet de l'augmentation des taux d'oestrogène on va voir l'augmentation et le développement des lobes et lobules et surtout des acinies au cours de la grossesse d'où l'augmentation du volume mammaire au cours de la grossesse et aussi des canaux galactophores. Donc la sécrétion de prolactine comme on l'a vu est bloquée donc la sécrétion de prolactine est importante mais son action sur le sein est bloquée par les oestrogènes donc là la lactation va se dérouler en trois étapes nécessaires à la mise en place c'est la mammogénèse c'est ce qu'on vient de voir, la lactogénèse et la galactopoïèse.

Donc la mammogénèse donc le développement des seins comme on l'a vu va être achevé au cours de la grossesse par l'augmentation du nombre de canaux galactophores sous l'effet des oestrogènes, pardon des galactophores sous l'effet des progestatifs ou de la progestérone et des acinies sous l'effet des oestrogènes avec une augmentation de la prolactine. La lactogénèse c'est la production de lait donc qui va commencer immédiatement après l'accouchement du fait de la chute des oestrogènes donc la prolactine va stimuler la production de lait et donc l'entretien de cette sécrétion va être stimulé par la cession du sein qui va stimuler l'hypophyse qui va sécréter la prolactine. La galactopoïèse c'est la phase d'éjection de lait et qui est évidemment provoquée par la cession. Donc sous l'effet de l'ocytocine qui va entraîner la contraction des cellules musculaires, des acinies mais aussi du muscle areolaire on va voir l'éjection du lait.

La production de la prolactine et de l'ocytocine est très influencée par les émotions notamment le stress qui peut bloquer et les pleurs des bébés qui vont stimuler. Donc la régulation de la lactation est principalement liée au rythme des tétés donc la production de lait va dépendre de leur fréquence et de leur régularité c'est pour ça qu'on conseille aux patients de commencer l'allaitement le plus tôt possible avec des fréquences importantes afin d'améliorer la qualité de la montée laiteuse et aussi d'entretenir sa sécrétion. Donc les étapes de la lactation en général sont subdivisées en 4 étapes les premières 48 heures on va avoir la sécrétion du colostrum la deuxième étape c'est la montée laiteuse, la troisième c'est ce qu'on appelle la période de

croisière qui peut durer plusieurs semaines jusqu'à plusieurs années.

Le sevrage qui met fin à ce processus d'allaitement maternel. Donc le colostrum constitue le premier lait donc qui est un lait particulier qui est épais de faible volume qui est aussi de couleur différente qui est jaune orangé et non pas blanc qui est spécialement adapté aux besoins du nouveau-né durant les premières heures voire les premiers jours de la naissance. Il est très riche en anticorps et il est peu chargé en graisse et riche en glucides pour être adapté aux capacités enzymatiques de digestion du nouveau-né donc il va favoriser l'émission du méconium, il se digère très vite et donc il peut être consommé toutes les heures sans aucun problème.

Donc la première mise au sein doit être précoce durant les deux heures suivantes suivant la naissance pour le bon déroulement de la lactation. Donc il n'y a pas de rythme recommandé et donc on conseille aux patients de donner le sein à la demande. Une autre information que en général le colostrum a la même composante c'est à dire le démarrage et le début de la tétée jusqu'à la fin il n'y a pas de modification de la qualité de ce lait et c'est pour ça qu'on peut conseiller aux femmes de donner les deux seins à la même tétée à la différence du lait au cours de la période de croisière qu'on va voir tout de suite.

Donc la montée laiteuse va s'installer en général vers le deuxième ou le troisième jour suite à l'activation de la prolactine et son action sur le sein les seins suite à la production importante de lait vont devenir tendus avec une sensation de chaleur cette montée laiteuse peut être accompagnée parfois d'un petit fébricule qui est passager et qui est fréquent et c'est le début de la lactation. Donc le lait est encore clair mais il est déjà plus riche en sucre et en graisse et il est toujours adapté aux capacités digestives du bébé et à ses besoins. La quantité de lait est de plus en plus importante et va être conditionnée par le nombre de tétées qui va stimuler la sécrétion de la prolactine et donc entretenir la production de lait.

La prolactine augmente déjà au cours de la grossesse mais son action était bloquée par les œstrogènes juste après l'accouchement. Si la patiente a pris des médicaments pour l'arrêt de l'allaitement, la chute de la prolactine va être immédiate. Si la patiente n'allait pas, cette chute va être progressive jusqu'au quatorzième jour.

Si la patiente allaite, on aura un entretien de la sécrétion de la prolactine et qui va diminuer par la suite vers le quarantième jour et rester basse même avec l'allaitement par la suite. La troisième phase, c'est la période de croisière qui va s'installer vers le quinzième jour où la sécrétion va devenir constante et stable avec un lait qui est riche en sucre et en graisse et la tétée qui est de plus en plus nourrissante, plus longue et moins fréquente. En général, le lait du début de la tétée est différent de la fin de la tétée.

En général, les glucides sont livrés au début, puis par la suite les lipides à la fin de la tétée. C'est pour ça qu'il faut conseiller aux femmes de donner un sein par tétée. Même si les tétées se font à la demande, elles sont en général au bout de 8 par 24 heures.

L'allaitement est quelque chose de très important et qui a beaucoup de bienfaits pour la patiente et pour son nouveau-né. C'est le lait le plus adapté au nouveau-né, à ses capacités digestives. Il a aussi un rôle immunitaire avec sa contenance en anticorps.

Il apporte des éléments essentiels à la bonne croissance, diminue le risque d'obésité et de diabète chez l'enfant, améliore le contact et donc la relation mère-enfant et aussi diminue le risque de cancer chez la mère. Ce risque est lié à la durée et au nombre d'enfants qui sont allaités. Est-ce qu'il y a une hygiène de vie particulière à conseiller aux patientes qui allaitent? Oui, il faut surtout conseiller le lavage des mains afin de réduire le risque infectieux.

Il n'y a pas du tout besoin de nettoyer le sein avant chaque tété. Le mamelon normalement doit être toujours séché et maintenu à sec après chaque tété afin d'éviter les complications, la macération, ce qu'on appelle les crevasses. Question qui revient toujours par les patientes, est-ce qu'il y a une alimentation spécifique pour améliorer la production de lait? C'est surtout une alimentation riche et variée et avec une bonne hydratation et éviter surtout les boissons alcoolisées et le tabac qui sont aussi les produits et les substances excitantes.

Il faut favoriser, comme on a dit, une bonne hydratation et boire beaucoup d'eau et de liquide. En cas d'engorgement, on peut conseiller une restriction hydrique quelques jours. Il n'y a pas d'aliments interdits mais certains aliments qui sont épicés peuvent donner du goût et de l'odeur au lait donc ils doivent être adaptés au goût du bébé.

Si le bébé refuse le sein après la consommation de certains aliments, il vaut mieux les éviter. Une chose importante sur laquelle il faut insister afin d'aider la patiente à réussir son allaitement, c'est la position de mise de sein pour d'abord améliorer la qualité de la succion et donc la nutrition et deuxièmement éviter les complications notamment le lombago qui peut survenir chez la patiente à cause d'une mauvaise posture lors de la TTT. En général, les patients ont peur d'asphyxier leur nouveau-né et de ce fait là, ils vont donner juste le mamelon au niveau de la bouche du nouveau-né.

Il faut leur expliquer qu'ils doivent être en position confortable, soit en position assise avec un dos qui est soutenu ou bien en position allongée sur le côté. Il faut aussi expliquer aux patientes que toute la région areolaire doit être introduite au niveau de la bouche du bébé afin de favoriser le mécanisme d'allaitement qui se fait par la compression des sinus galactophores entre le palais du nouveau-né et la base de la langue. Donc le bébé doit être placé face au ventre de la femme, sa bouche bien en face de l'aréole, sa tête dans l'alignement de son corps, sinon il aura du mal à avaler et il faut qu'il attrape le sein avec une bouche grande ouverte pour prendre l'ensemble de l'aréole comme on vient de l'expliquer.

Ainsi, le mamelon est collé au palais et la langue du bébé va entraîner un mouvement de compression qui va permettre l'éjection du lait. En général, le bébé va avoir son menton et son nez collés sur le sein, il faut l'expliquer aux patientes, il n'y a pas de risque d'asphyxie et donc

c'est le réflexe de foussement, il n'y a pas de risque pour sa respiration comme on a bien dit. Des informations aussi importantes pour les patientes, surtout les femmes qui travaillent ou qui étudient, le lait maternel peut être stocké à température ambiante pendant 4 heures dans le réfrigérateur 5 à 7 jours et dans le congélateur 6 à 7 mois et de ce fait là, il peut être stocké et ensuite donné au nouveau-né dans un biberon si la patiente sort pour travailler ou même si elle voyage.

Donc si ces conditions ne sont pas respectées, on peut avoir des complications spécifiques à l'allaitement et le premier type de complications et qui est le plus fréquent, c'est les crevasses qui sont des fissures ou des ulcérations suite à une macération de la région du mamelon qui sont le plus souvent secondaires à une mauvaise technique d'allaitement. Donc elles sont très douloureuses, souvent à l'origine de demandes d'arrêt d'allaitement qui peuvent être favorisées par des tétés prolongés, un mamelon court et emboliqué et une mauvaise technique et une mauvaise position du bébé ou par un manque d'hygiène. En général, il faut conseiller aux patientes l'application de crèmes cicatrisantes, corriger la position de l'allaitement, le nettoyage avant et après chaque tété afin d'éviter la réapparition.

Deuxième complication, c'est l'engorgement mammaire qui est dû à une mauvaise vidange et là aussi secondaire à une mauvaise technique d'allaitement. Donc les seins qui vont devenir gonflés à cause de la non-vidange du lait vont devenir durs, douloureux et tendus et peuvent parfois s'accompagner d'un fébricule voire d'une fièvre. La prise en charge, c'est l'évacuation des seins qui va être favorisée par des douches chaudes suivies d'expressions manuelles ou de tirelets avec une restriction hydrique sur quelques jours.

Si cet engorgement ne régresse pas ou s'il est très important, on peut s'aider de l'utilisation d'une injection d'ocytocine qui va favoriser l'évacuation du sein. On peut aussi prescrire de l'aspirine qui va diminuer l'inflammation mais aussi réduire la production de lait. Donc c'est une prescription sur uniquement 24 heures.

Si l'engorgement n'est pas pris en charge, il peut évoluer vers une inflammation du sein mais qui n'est pas suppurée, ce qu'on appelle la lymphangite aiguë qui est la première complication des crevasses et de l'engorgement et qui va se manifester cliniquement par un début brutal avec une hyperthermie donc c'est une vraie fièvre avec des seins qui sont douloureux et à l'examen un placard localisé rouge et chaud avec parfois une adénopathie axillaire. Donc le traitement c'est il faut maintenir l'allaitement application de compresses alcoolisées parfois nécessité d'introduire une antibiotérapie qui doit être adaptée à l'allaitement. L'évolution est en général rapidement régressive sous ces traitements physiques avec ou sans antibiotérapie et donc l'intérêt de la prévention.

Les choses peuvent évoluer vers une phase infectieuse où on va avoir une inflammation plus importante avec une hyperthermie, avec une douleur importante et des seins qui sont tendus et on peut à l'expression du mamelon avoir l'extériorisation d'une tache de peau. Donc c'est des cas

où il va falloir allaiter par l'autre sein et continuer à tirer le lait du sein infecté, traiter par antibiotérapie adaptée et aussi favoriser la vidange du sein par des douches chaudes avec l'utilisation soit d'évacuation manuelle ou de de tirer le lait. Les choses peuvent évoluer encore plus de manière plus importante vers un abcès et donc collecter, c'est ce qu'on appelle la phase supérative, c'est la mastite du sein avec parfois même fistulisation.

Donc à l'examen clinique tout le sein est rouge avec une collection avec une fluctuation. Sur le plan général on aura une température importante et un sein très douloureux. Donc là le traitement est basé sur l'antibiothérapie systématique et le drainage chirurgical de l'abcès.

Il faut conseiller à la patiente des règles d'hygiène strictes et lui dire aussi qu'elle peut continuer à allaiter par l'autre sein. En conclusion, la période de retour de couche ou de suite de couche c'est la période de retour du corps maternel à la physiologie et à la normale. Donc plusieurs modifications physiologiques, psychologiques et aussi sociales avec un risque de complication qu'il faut guetter et prévenir par une surveillance et un suivi post-hospitalier important.

Je vous remercie.